OPOSICIÓN TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) — AYUNTAMIENTO DE UTRERA | BOP SEVILLA 102 (29/05/2026)

Tema 40 — El Duelo. Concepto del duelo. Descripción de cada una de las fases del proceso de duelo. Metodología y plan de trabajo ante el duelo. Resolución del duelo y procesos de cierre

1. Concepto del Duelo y Delimitación Terminológica

El duelo constituye uno de los fenómenos existenciales y psicosociales más universales, complejos e ineludibles de la experiencia humana. Lejos de constituir un estado patológico o una enfermedad mental en sí mismo, el duelo es la **respuesta biopsicosocial, emocional, cognitiva, conductual y espiritual natural y adaptativa** que experimenta un individuo, una familia o una comunidad ante la **pérdida significativa e irreversible** de una persona, vínculo, objeto, función corporal o proyecto vital.

En el marco de la intervención de los Servicios Sociales Comunitarios y, de manera específica, desde la práctica profesional del **Educador o Educadora Social**, el duelo se aborda como un proceso dinámico de transición vital y reestructuración pedagógica del sentido del mundo, que requiere acompañamiento socioeducativo en el medio natural, prevención del aislamiento y capacitación de la persona doliente para reconstruir su vida cotidiana.

1.1. Delimitación Terminológica: La Tríada Conceptual Clásica

En la literatura científica internacional y en las pruebas selectivas de acceso a la función pública, es preceptivo dominar la diferenciación terminológica anglosajona y castellana que delimita con precisión el suceso objetivo, la vivencia subjetiva y la manifestación sociocultural:

LA TRÍADA CONCEPTUAL CLÁSICA ANTE LA PÉRDIDA		
1. PÉRDIDA (BEREAVEMENT)	2. DUELO (GRIEF)	3. LUTO (MOURNING)
Suceso o hecho objetivo de privación de algo o alguien significativo. Estado en el que queda quien sufre la pérdida.	Reacción subjetiva, interna y multidimensional (emocional, cognitiva, fisiológica y conductual) desencadenada por el hecho de la pérdida.	Manifestación externa, social, cultural, ritual y conductual prescrita por el grupo o la comunidad para expresar el duelo (funerales, velatorios).

- **Pérdida (*Bereavement*)**: Hace referencia al acontecimiento fáctico u objetivo de verse privado de algo o alguien de gran valor afectivo o funcional. Define la situación objetiva en la que se encuentra la persona doliente tras el fallecimiento o la ruptura.
- **Duelo (*Grief*)**: Proviene etimológicamente del latín *dolus* (dolor) y *duellum* (combate, lucha interna). Es la vivencia psicológica y emocional íntima ante la pérdida. Abarca el sufrimiento, la tristeza, el anhelo, la culpa, el desconcierto y los cambios fisiológicos y actitudinales.
- **Luto (*Mourning*)**: Alude al conjunto de expresiones externas, ritos sociales, comportamientos pautados y convenciones culturales (vestimenta de color determinado, ceremonias funerarias, periodos de aislamiento social formal) mediante los cuales una sociedad o comunidad acoge, canaliza, valida e integra la muerte o la separación.

1.2. Factores Determinantes y Moduladores del Proceso de Duelo

El impacto y la evolución temporal del duelo no siguen un patrón homogéneo ni predeterminado; están profundamente condicionados por una constelación de factores interactivos:

1. **Naturaleza del vínculo y tipo de apego**: La intensidad del duelo guarda relación directa con el grado de dependencia, cercanía afectiva, ambivalencia emocional o conflictos no resueltos con la figura perdida (los apegos ansiosos o dependientes suelen correlacionar con duelos crónicos o complicados).
2. **Circunstancias y tipología de la muerte**:

- *Muerte esperada o tras enfermedad crónica*: Permite la activación del duelo anticipatorio y la despedida gradual.
- *Muerte repentina, traumática, violenta o por accidente*: Genera un elevado nivel de shock, sensación de irrealidad y mayor vulnerabilidad al trauma.
- *Muerte por suicidio*: Frecuentemente asociada a sentimientos abrumadores de culpa, estigma social, vergüenza y necesidad obsesiva de buscar explicaciones (*"¿por qué?"*).
- *Desapariciones o ausencia de cadáver*: Dificulta la constatación fáctica de la muerte, impidiendo el inicio ordenado de los rituales de cierre.

1. **Variables individuales del doliente**: Edad cronológica y momento evolutivo (infancia, adolescencia, adultez, vejez), madurez cognitiva, recursos de afrontamiento (*coping*), historial previo de pérdidas y presencia de patología mental previa.
2. **Entorno sociofamiliar y red de apoyo**: Disponibilidad de una red de apoyo informal empática y contenedora, situación de estabilidad socioeconómica y pertenencia a una comunidad que valide abiertamente el dolor sin imponer silencios ni prisas artificiales.

---

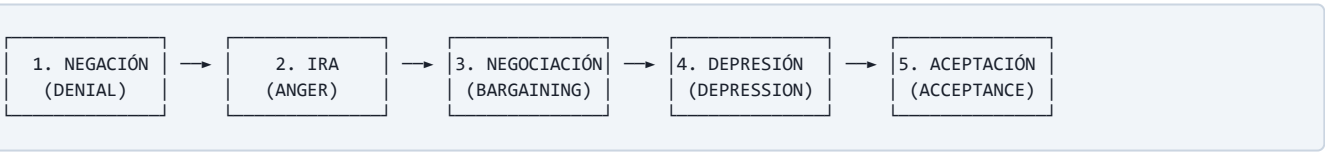
2. Descripción de las Fases y Modelos Teóricos del Proceso de Duelo

El estudio científico del duelo ha evolucionado desde concepciones pasivas basadas en etapas lineales rígidas hacia modelos activos fundamentados en tareas, procesos duales y reconstrucción de significados.

2.1. El Modelo de Fases de Elisabeth Kübler-Ross (1969)

En su célebre obra *On Death and Dying* (1969), la psiquiatra suizo-estadounidense **Elisabeth Kübler-Ross** describió por primera vez las reacciones psicológicas de los pacientes ante el diagnóstico de una enfermedad terminal, modelo que posteriormente se extrapoló a los procesos de duelo en familiares y personas allegadas.

Kübler-Ross sistematizó el proceso en **cinco etapas sucesivas**:



1. **Negación (*Denial*)**:

- *Mecanismo*: Funciona como un amortiguador psíquico inicial o mecanismo de defensa temporal que protege al individuo del colapso emocional ante una noticia abrumadora (*"Esto no me puede estar pasando a mí"*, *"Tiene que haber un error en los análisis"*).
- *Manifestación*: Aturdimiento, incredulidad y aislamiento momentáneo.

1. **Ira (*Anger*)**:

- *Mecanismo*: Al disiparse la negación y hacerse insoslayable la realidad, el dolor se transforma en rabia, hostilidad, envidia y resentimiento proyectado hacia el exterior (*"¿Por qué a mí?"*, *"¿Por qué Dios lo permite?"*, *"¿Por qué los médicos no hicieron más?"*).
- *Destinatarios*: Familiares, profesionales sanitarios, Dios o incluso la propia persona fallecida por haber abandonado al doliente.

1. **Negociación (*Bargaining*)**:

- *Mecanismo*: Intento defensivo y desesperado de posponer o mitigar la pérdida mediante pactos o promesas, generalmente de naturaleza espiritual, religiosa o moral (*"Dios mío, si le salvas la vida iré a misa todos los domingos y cambiaré mi forma de ser"*).
- *Finalidad*: Recuperar una sensación ilusoria de control sobre un suceso incontrolable.

1. **Depresión (*Depression*)**:

- *Mecanismo*: Toma de conciencia plena de la definitividad de la pérdida. Emerge una profunda tristeza reactiva ante el vacío dejado.
- *Subtipos descritos por Kübler-Ross*:
- *Depresión reactiva*: Vinculada a las pérdidas ya consumadas (pérdida económica, de estatus, de compañía).
- *Depresión preparatoria*: Vinculada a las pérdidas futuras y a la preparación para la separación final.

1. **Aceptación (*Acceptance*)**:

- *Mecanismo*: No equivale a alegría ni a felicidad, sino a una etapa de **paz serena y desapego emocional tranquilo**.
- *Manifestación*: La persona asume la realidad de la ausencia, disminuye la lucha interna y se produce una reorganización del mundo vital.

> **[IMPORTANT] Advertencia técnica de examen**: La propia Elisabeth Kübler-Ross y la literatura moderna subrayan que estas etapas **no son lineales, fijas ni prescriptivas**. Un doliente no transita mecánicamente del punto 1 al punto 5; puede fluctuar, saltarse fases, experimentar varias simultáneamente o retroceder ante aniversarios o fechas señaladas.

2.2. El Modelo de Apego y Fases de John Bowlby y Colin Murray Parkes (1980)

Fundamentado en la **Teoría del Apego**, **John Bowlby** y el psiquiatra británico **Colin Murray Parkes** formularon en 1980 un modelo de cuatro fases basado en las conductas instintivas de búsqueda de proximidad ante la pérdida de una figura de apego significativa:

1. **Fase de Embotamiento de la Sensibilidad (*Numbing*)**:

- Dura desde unas horas hasta varios días tras el suceso. Se caracteriza por un estado de shock psicógeno, aturdimiento, desconexión afectiva y ocasionales estallidos de angustia o cólera extrema.

1. **Fase de Anhelo y Búsqueda (*Yearning and Searching*)**:

- Puede durar meses. Se caracteriza por una búsqueda activa e instintiva de la persona perdida (mirar fotos, buscar su rostro entre la multitud, escuchar su voz o sentir su presencia física). Emerge una profunda inquietud motora, sollozos y rabia defensiva.

1. **Fase de Desorganización y Desesperanza (*Disorganization and Despair*)**:

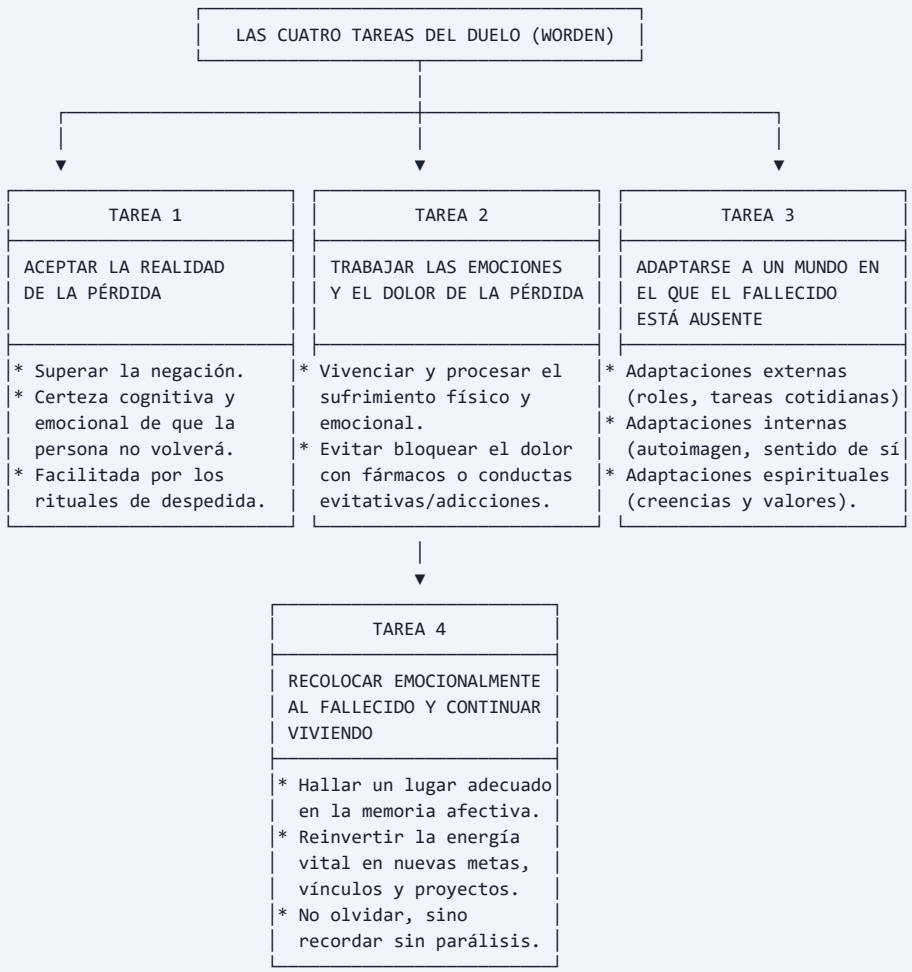
- Se constata la inutilidad de la búsqueda. El doliente experimenta apatía, pérdida de apetito, abatimiento y una profunda sensación de vacío y pérdida de propósito en la vida cotidiana.

1. **Fase de Reorganización (*Reorganization*)**:

- Se asume la definitividad de la pérdida. Comienza la reconstrucción de la identidad y de los patrones de vida diaria. Se forman nuevos apegos y se recupera la capacidad de disfrutar sin sentimientos de traición.

2.3. El Modelo de las Cuatro Tareas Activas de J. William Worden (1991/2009)

El psicólogo clínico **J. William Worden** supuso una auténtica revolución epistemológica al sustituir el paradigma pasivo de las "fases" (donde el doliente sufre o espera a que el tiempo cure) por un **modelo de tareas activas (*Grief Tasks*)**, donde la persona doliente es un sujeto activo que debe realizar un trabajo psicológico y socioeducativo específico:



1. **Tarea 1: Aceptar la realidad de la pérdida**:

- El doliente debe asumir con plena lucidez que la persona ha muerto, que la separación es definitiva y que no regresará. Implica superar tanto la negación de los hechos (*"no es verdad"*) como la negación del significado (*"no era tan importante"*) o la negación de la irreversibilidad (almacenar sus pertenencias intactas como si fuera a volver). Los rituales funerarios y velatorios son facilitadores pedagógicos esenciales de esta tarea.

1. **Tarea 2: Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida**:

- Es imprescindible vivenciar, validar y expresar el dolor emocional, la rabia, la culpa y la tristeza. Bloquear o anestesiar el dolor (mediante medicalización abusiva, aislamiento o hiperactividad laboral compensatoria) enquista el proceso y genera patologías somáticas o psicológicas a medio plazo.

1. **Tarea 3: Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente**:

- Worden desglosa esta tarea en tres dimensiones adaptativas esenciales:
- *Adaptaciones externas*: Aprender a desempeñar los roles, tareas y funciones prácticas que realizaba el fallecido (administrar la economía doméstica, cocinar, reparar la vivienda, cuidar de los menores).

- *Adaptaciones internas*: Redefinir la propia identidad personal y el autoconcepto (*"¿quién soy yo ahora que no soy su marido/madre/hijo?"*).
- *Adaptaciones espirituales*: Reconfigurar las creencias sobre el mundo, la justicia y el sentido de la vida.

1. **Tarea 4: Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo**:

- En sus primeras ediciones (1991), Worden denominaba a esta tarea *"retirar la energía emocional del fallecido y reinvertirla en otras relaciones"*. En su revisión de 2009, reformuló el concepto hacia la **reubicación o recolocación emocional**: no se trata de olvidar o desvincularse, sino de encontrar un lugar apropiado para el ser querido en la memoria emocional y autobiográfica del doliente, permitiéndole continuar viviendo con plenitud y abrirse a nuevos vínculos y proyectos de futuro sin culpa.

2.4. El Modelo del Proceso Dual de Margaret Stroebe y Henk Schut (1999)

Margaret Stroebe y Henk Schut (1999) propusieron un modelo dinámico e interactivo que describe el duelo como un proceso constante y adaptativo de **oscilación (*oscillation*)** entre dos orientaciones complementarias:

- **Orientación hacia la Pérdida (*Loss-Orientation*)**: Concentración de la atención en la persona fallecida, el dolor del apego, el llanto, el recuerdo nostálgico y las circunstancias de la muerte.
- **Orientación hacia la Restauración (*Restoration-Orientation*)**: Concentración de la atención en el afrontamiento de las consecuencias prácticas de la pérdida, la reorganización de la vida diaria, el aprendizaje de nuevas habilidades, la distracción deliberada y la proyección hacia el futuro.

El duelo saludable no consiste en instalarse permanentemente en la pérdida ni en reprimirla volcándose compulsivamente en la restauración, sino en la **capacidad fluida de oscilar entre el dolor de la ausencia y las demandas de la vida cotidiana**.

2.5. El Enfoque Constructivista de Robert A. Neimeyer (2001)

Robert A. Neimeyer aborda el duelo desde una perspectiva constructivista y narrativa, definiéndolo como un **proceso activo de reconstrucción del significado**. La pérdida de un ser querido quiebra la narrativa vital previa (*la historia que nos contábamos sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo*). La labor del doliente consiste en tejer una nueva narrativa que integre la muerte traumática, dotándola de coherencia y sentido dentro de la propia biografía.

---

3. Tipologías de Duelo y Criterios Diagnósticos del Duelo Complicado

La intervención profesional exige diferenciar con nitidez el duelo evolutivo de aquellas modalidades que, por su curso o circunstancias, requieren un abordaje socioeducativo específico o una derivación urgente a la red de salud mental.

3.1. Tipologías Clínicas y Sociales del Duelo

1. **Duelo Normal o Evolutivo**: Proceso adaptativo con respuestas afectivas, cognitivas y físicas proporcionadas, de curso fluctuante y progresiva remisión sintomática sin necesidad de psicofármacos ni intervención clínica intensiva.
2. **Duelo Anticipatorio**: Se experimenta de forma previa al fallecimiento real, con frecuencia durante enfermedades terminales o degenerativas prolongadas (como demencias o cáncer avanzado). Permite cerrar conversaciones pendientes, resolver conflictos y preparar emocionalmente la despedida, si bien puede generar un agotamiento previo extremo en los cuidadores.
3. **Duelo Retardado o Inhibido**: La persona no manifiesta externamente dolor ni tristeza tras la pérdida, manteniendo una aparente normalidad o frialdad emocional (a menudo porque asume el rol de "sostén" de

otros miembros vulnerables). El duelo reprimido suele eclosionar de forma diferida meses o años después ante un detonante menor.

4. **Duelo Crónico**: Presenta una duración temporal excesiva y estancada, sin que el doliente experimente ningún avance en las tareas del duelo, manteniendo intacta la intensidad del sufrimiento del primer día durante años.
5. **Duelo Desautorizado o Silenciado (*Disenfranchised Grief*, Kenneth Doka, 1989)**:

- *Concepto clave de examen*: Aquel duelo que **no es reconocido, validado o apoyado abiertamente por la sociedad o el entorno cultural**.
- *Ejemplos típicos*: Duelo perinatal (muerte del feto en el embarazo o al nacer), abortos provocados, suicidio o muerte por sobredosis (asociados a estigma), pérdida de exparejas, relaciones extramatrimoniales no públicas, pérdida de personas con discapacidad intelectual grave o pérdida de mascotas de compañía. Al carecer de validación y rituales sociales, el doliente experimenta un profundo aislamiento y soledad.

1. **Duelo Ambiguo (Pauline Boss, 1999)**:

- *Tipo 1*: **Ausencia física con presencia psicológica** (la persona está físicamente desaparecida pero permanece psicológicamente viva en la mente del doliente: secuestros, naufragios, desapariciones de guerra, migración forzada).
- *Tipo 2*: **Presencia física con ausencia psicológica** (la persona está físicamente viva pero ha perdido su identidad o conexión psicológica: enfermedad de Alzheimer, demencias graves, coma vegetativo irreversible o daño cerebral severo).

1. **Duelo Migratorio (Joseba Achotegui)**: Duelo múltiple, recurrente y crónico experimentado por personas migrantes ante la pérdida simultánea de la lengua, la cultura, la familia, el estatus social, la tierra y el grupo de pertenencia, vinculado al denominado **Síndrome de Ulises**.

3.2. Criterios Diagnósticos Oficiales del Duelo Complicado o Prolongado

Los dos principales sistemas nosológicos internacionales han incorporado formalmente el duelo patológico como una categoría diagnóstica diferenciada de la depresión mayor y del trastorno de estrés postraumático:

Manual Diagnóstico	Denominación Oficial	Código	Criterio Temporal Mínimo
CIE-11 (OMS, 2022)	**Trastorno por duelo prolongado**	**6B42**	Persistencia superior a **6 meses** desde el fallecimiento.
DSM-5-TR (APA, 2022)	**Trastorno de duelo prolongado**	**F43.8**	Al menos **12 meses en adultos** y al menos **6 meses en niños y adolescentes**.

Criterios Clínicos Esenciales (DSM-5-TR):

- Anhelo o añoranza intensa y persistente por la persona fallecida o preocupación constante por las circunstancias de la muerte.
- Presencia de al menos tres de los siguientes síntomas la mayor parte del tiempo:

1. Sentimiento de incredulidad o incapacidad para aceptar la definitividad de la muerte.
2. Dolor emocional intenso (amargura, ira, tristeza profunda) en relación con la pérdida.
3. Confusión de identidad o sentimiento de que una parte de sí mismo ha muerto con el fallecido.
4. Evitación persistente de recordatorios de la pérdida.
5. Entumecimiento emocional o incapacidad para experimentar emociones positivas.
6. Sentimiento de que la vida carece de sentido o propósito sin la persona.

7. Soledad intensa o desconexión social de los demás.

- Deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, escolar o laboral.
- La duración y gravedad de la reacción exceden claramente las normas sociales, culturales o religiosas del entorno del individuo.

---

4. Metodología y Plan de Trabajo Ante el Duelo desde la Educación Social

4.1. Delimitación Competencial: Educación Social vs. Psicología

En el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios (y en el marco del trabajo interdisciplinar regulado por el artículo 30 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía), es imprescindible delimitar el campo competencial de la intervención:

DESLINDE COMPETENCIAL EN EL ABORDAJE TÉCNICO DEL DUELO	
EL/LA EDUCADOR/A SOCIAL (A2)	EL/LA PSICÓLOGO/A (A1)
* Intervención socioeducativa y pedagógica en el medio natural. * Acompañamiento en la vida cotidiana (hábitos, rutinas, organización hogar). * Alfabetización y validación emocional. * Reestructuración de dinámicas familiares y capacitación parental ante el duelo. * Intervención escolar y coordinación con centros educativos (EOE/DO). * Dinamización del ocio y red comunitaria	* Diagnóstico clínico psicopatológico y pericial. * Psicoterapia clínica individual o familiar especializada. * Abordaje del trauma complejo y desregulación emocional severa. * Tratamiento psicofarmacológico (coordinación con USMC/psiquiatría). * Duelo patológico o complicado (CIE-11 6B42 / DSM-5-TR).

El/La Educador/a Social **no realiza psicoterapia clínica**, sino que actúa como un agente pedagógico y relacional de acompañamiento que facilita la reorganización de la vida cotidiana, la expresión emocional normalizada y la reinserción social y comunitaria de la persona o unidad familiar en duelo.

4.2. El Duelo en la Infancia y la Adolescencia: Peculiaridades Evolutivas

La intervención socioeducativa con niños, niñas y adolescentes requiere comprender cómo evoluciona el concepto de la muerte según el estadio del desarrollo cognitivo:

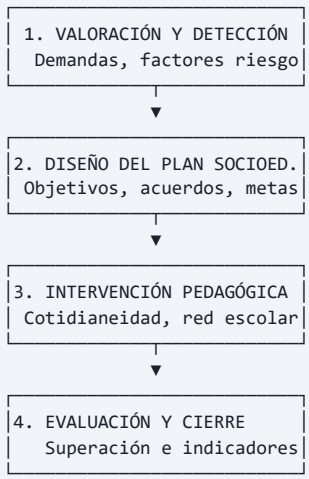
- **De 0 a 2 años**: No existe comprensión cognitiva de la muerte. Reaccionan a la ausencia física de la figura de apego mediante ansiedad por separación, irritabilidad, alteraciones del sueño y cambios en los ritmos biológicos.
- **De 3 a 5 años (Pensamiento Mágico)**: Conciben la muerte como algo **temporal y reversible** (la persona está "dormida" o "de viaje" y puede regresar). Predomina el pensamiento mágico y el egocentrismo, pudiendo albergar sentimientos de culpa (*"se ha muerto porque me porté mal"*).
- **De 6 a 9 años**: Comienzan a comprender los componentes de **irreversibilidad** y **cese de las funciones corporales**, pero a menudo personifican la muerte (un monstruo, el hombre del saco) y temen por la muerte de otras figuras protectoras.
- **A partir de los 9-10 años**: Adquieren el concepto adulto de muerte en sus cuatro componentes universales:

1. **Universalidad**: Todos los seres vivos mueren inevitablemente.
2. **Irreversibilidad**: Una vez muerto, no hay retorno físico posible.
3. **No funcionalidad**: Todas las funciones biológicas y fisiológicas cesan por completo.
4. **Causalidad**: La muerte obedece a causas físicas objetivas (enfermedad, accidente, vejez).

- **Adolescencia**: Comprensión adulta plena combinada con crisis de identidad, confrontación de la propia vulnerabilidad existencial, tendencia al aislamiento entre iguales o conductas de riesgo reactivas (consumo de sustancias, acting out) para enmascarar el dolor.

4.3. Fases Operativas del Plan de Trabajo Socioeducativo ante el Duelo

El diseño del plan de trabajo socioeducativo en los Servicios Sociales Comunitarios (integrado en el Proyecto de Intervención Social o en un Proyecto Educativo Individualizado) se estructura en cuatro etapas operativas:



Fase 1: Valoración y Detección de Necesidades Socioeducativas

- Recogida de información sobre las circunstancias de la pérdida, dinámicas de apego y recursos familiares.
- Evaluación del impacto del duelo en la vida cotidiana: desatención higiénica o alimentaria, absentismo escolar, abandono de aficiones, aislamiento social o colapso de las rutinas domésticas.
- Detección de factores de vulnerabilidad que aconsejen la interconsulta o derivación inmediata a Psicología o a la Unidad de Salud Mental Comunitaria (ideación suicida, desconexión de la realidad, depresión mayor).

Fase 2: Formulación de Objetivos y Diseño del Plan de Trabajo

- Formulación consensuada de objetivos socioeducativos adaptados a la persona o familia doliente:
- Facilitar la expresión verbal y no verbal del dolor emocional.
- Reestructurar los horarios de sueño, comidas y actividades de ocio estructurado.
- Normalizar el rendimiento y la asistencia al centro escolar.
- Desarrollar habilidades para asumir nuevas tareas cotidianas dejadas vacantes por el fallecido.
- Reconstruir la red de apoyo social informal.

Fase 3: Ejecución de la Intervención Socioeducativa

- **Intervención directa en el medio natural y a domicilio**:
- *Alfabetización y validación emocional*: Enseñar que la tristeza, el llanto, el desconcierto e incluso la rabia son respuestas legítimas y necesarias que no deben reprimirse.
- *Técnicas de expresión lúdica y narrativa en infancia*: Uso de cuentos pedagógicos sobre la muerte, dibujo libre, modelado con plastilina o arcilla, teatro de marionetas y redacción de diarios emocionales.
- *Proscripción de eufemismos perjudiciales*: Orientar a los progenitores para que eviten expresiones confusas como *"mamá se ha dormido para siempre"* (provoca fobias al sueño infantil) o *"el abuelo se ha ido de viaje"* (genera ansiedad de abandono y falsas esperanzas de retorno). Utilizar un lenguaje claro, honesto y adecuado a su edad: *"ha muerto, su corazón ha dejado de latir y ya no siente dolor"*.

- *Reestructuración de la vida diaria en el hogar*: Confección de cuadrantes de tareas domésticas, reorganización de la economía y reasignación equitativa de responsabilidades familiares sin parentificar a los menores.
- **Coordinación Intersectorial en el Ámbito Escolar**:
- Contacto directo y continuado con el tutor docente, la Jefatura de Estudios y el Equipo de Orientación Educativa (EOE) o Departamento de Orientación (DO).
- Implementación de protocolos de duelo en el aula: acondicionar espacios de calma para momentos de desbordamiento, flexibilizar transitoriamente plazos de exámenes y evitar la estigmatización o el silenciamiento compasivo del menor por sus compañeros.

Fase 4: Evaluación y Seguimiento

- Monitorización periódica de indicadores conductuales y socioemocionales de adaptación.
- Evaluación compartida en la Comisión Técnica de Valoración o en reuniones interdisciplinares del centro de servicios sociales.

---

5. Resolución del Duelo y Procesos de Cierre

5.1. Indicadores de Resolución Saludable y Adaptativa

El duelo no concluye cuando se olvida al ser querido, sino cuando el recuerdo deja de ser una herida paralizante para convertirse en un legado afectivo integrado en la propia biografía.

Los indicadores técnicos que evidencian la resolución positiva del proceso de duelo son:

1. **Capacidad de recordar con serenidad y afecto**: La persona es capaz de evocar vivencias, anécdotas y detalles del fallecido experimentando gratitud o nostalgia serena, sin que ello desencadene un dolor desbordante o paralizante.
2. **Reversión del embotamiento y reactivación emocional**: Recuperación plena de la capacidad de experimentar alegría, placer y satisfacción sin experimentar sentimientos irracionales de culpa o traición.
3. **Restablecimiento del funcionamiento adaptativo**: Recuperación del rendimiento laboral, formativo o escolar, y consolidación de hábitos saludables de autocuidado, nutrición y descanso.
4. **Reinvestidura afectiva y proyección de futuro**: Capacidad de establecer nuevos apegos, asumir compromisos sociales y laborales y trazar proyectos vitales a medio y largo plazo.
5. **Reconstrucción de la identidad personal**: Consolidación de un autoconcepto autónomo y resiliente tras la pérdida (*"he aprendido a vivir y a cuidarme sin él/ella"*).

5.2. Los Rituales de Despedida y Técnicas Pedagógicas de Cierre

Los rituales son construcciones simbólicas y pedagógicas de alto valor estructurador. Ayudan a conferir solemnidad al cierre, facilitan la expresión de lo inefable y delimitan la frontera entre el tiempo compartido en vida y el nuevo tiempo de la memoria:

1. **La Carta de Despedida y Gratitud**:

- Técnica socioeducativa consistente en escribir una carta dirigida a la persona fallecida dividida en cuatro bloques expresivos:

1. Lo que agradezco haber vivido y aprendido a tu lado.
2. Lo que me dolió o los conflictos que quedaron pendientes y hoy te perdono / te pido perdón.
3. Lo que voy a conservar de ti en mi corazón y en mi forma de actuar.
4. Mi adiós formal para que descanses en paz mientras yo continúo viviendo mi vida.

- La carta puede ser leída en sesión, quemada ritualmente o depositada en un lugar simbólico.

1. **La Caja de Recuerdos (*Memory Box*)**:

- Especialmente útil en la infancia y adolescencia. Consiste en decorar conjuntamente una caja física donde el menor deposita fotografías seleccionadas, un perfume, una carta, un objeto personal o un dibujo. Sirve como anclaje físico seguro: el menor sabe que el recuerdo está protegido allí y puede acudir a abrirla cuando sienta necesidad de conexión, evitando que el recuerdo invada descontroladamente todo el espacio vital.

1. **El Libro de la Vida o Álbum Biográfico**:

- Elaboración de un cuaderno narrativo y gráfico que recopila la historia de vida compartida, destacando los valores, frases típicas y enseñanzas transmitidas por la persona ausente.

1. **Actos de Homenaje y Ritos Simbólicos de Cierre**:

- Plantación de un árbol o flor conmemorativa en el jardín o parque comunitario; suelta simbólica de globos biodegradables con mensajes de despedida; o celebración de una comida familiar de memoria compartida al cumplirse un aniversario significativo.

---

6. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Autora del modelo de las 5 etapas del duelo**: **Elisabeth Kübler-Ross** (1969, obra *On Death and Dying*).
2. **Las 5 etapas de Kübler-Ross en orden**: **Negación (*Denial*)**, **Ira (*Anger*)**, **Negociación (*Bargaining*)**, **Depresión (*Depression*)** y **Aceptación (*Acceptance*)**.
3. **Autores del modelo de apego y las 4 fases del duelo**: **John Bowlby y Colin Murray Parkes** (1980).
4. **Las 4 fases de Bowlby y Parkes**: **Embotamiento de la sensibilidad (shock)**, **Anhelo y búsqueda**, **Desorganización y desesperanza**, y **Reorganización**.
5. **Autor del modelo de las 4 tareas activas del duelo**: **J. William Worden** (1991, revisado en 2009).
6. **Las 4 tareas de Worden**: 1) Aceptar la realidad de la pérdida; 2) Trabajar las emociones y el dolor; 3) Adaptarse a un medio donde el fallecido está ausente; 4) Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo.
7. **Autores del Modelo del Proceso Dual**: **Margaret Stroebe y Henk Schut** (1999).
8. **Ejes del Proceso Dual de Stroebe y Schut**: Oscilación entre la **Orientación a la pérdida** y la **Orientación a la restauración**.
9. **Autor del enfoque constructivista de reconstrucción del significado**: **Robert A. Neimeyer** (2001).
10. **Autor del concepto de Duelo Desautorizado (*Disenfranchised grief*)**: **Kenneth Doka** (1989).
11. **Autora del concepto de Duelo Ambiguo (presencia/ausencia física y psicológica)**: **Pauline Boss** (1999).
12. **Autor del concepto de Duelo Migratorio y Síndrome de Ulises**: **Joseba Achotegui**.
13. **Tríada conceptual clásica**: **Pérdida (*Bereavement*)** = suceso objetivo; **Duelo (*Grief*)** = respuesta subjetiva interna; **Luto (*Mourning*)** = expresión externa, cultural y ritual.
14. **Código y denominación en la CIE-11**: **Trastorno por duelo prolongado** (código **6B42**).
15. **Criterio temporal mínimo del duelo prolongado en la CIE-11**: Duración superior a **6 meses** desde el fallecimiento.

16. **Criterio temporal del Trastorno de Duelo Prolongado en el DSM-5-TR**: Al menos **12 meses en adultos** y al menos **6 meses en niños y adolescentes**.
17. **Edad en la que se adquiere el concepto adulto de muerte con sus 4 componentes**: Hacia los **9-10 años**.
18. **Los 4 componentes adultos del concepto de muerte**: **Universalidad**, **Irreversibilidad**, **No funcionalidad** (cese de funciones biológicas) y **Causalidad física**.
19. **Delimitación profesional básica**: El Educador/a Social realiza **acompañamiento socioeducativo, alfabetización emocional y estructuración de la vida cotidiana**; la Psicología realiza **psicodiagnóstico y psicoterapia clínica**.
20. **Técnicas pedagógicas clásicas de cierre ritual**: La **Carta de despedida y gratitud**, la **Caja de recuerdos (*Memory Box*)** y el **Álbum de vida**.
21. **Indicador esencial de resolución del duelo**: Capacidad de **recordar al ser querido con afecto sereno sin dolor invalidante** y reinvestir energía vital en el presente y futuro.
22. **Sede central de los Servicios Sociales Comunitarios en Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            MODELOS TEÓRICOS, TAREAS Y TIPOLOGÍAS DEL DUELO EN EXAMEN
================================================================================

 1. EL PROCESO DE DUELO SEGÚN LOS GRANDES AUTORES
    ├── KÜBLER-ROSS (1969)  ──► Fases: Negación -> Ira -> Negociación -> Depresión -> Aceptación
    ├── BOWLBY-PARKES (1980) ──► Apego: Embotamiento -> Anhelo/Búsqueda -> Desesperanza -> Reorganización
    ├── WORDEN (1991/2009)  ──► Tareas: 1. Aceptar realidad | 2. Trabajar dolor | 3. Adaptarse mundo | 4. Recolocar
    ├── STROEBE-SCHUT (1999) ──► Proceso Dual: Oscilación entre Orientación Pérdida <-> Restauración
    └── NEIMEYER (2001)     ──► Constructivismo: Reconstrucción del significado y narrativa vital

 2. TIPOLOGÍAS Y VARIANTES CLÍNICAS
    ├── DUELO ANTICIPATORIO ──► Previo al fallecimiento en enfermedades crónicas/terminales
    ├── DUELO DESAUTORIZADO ──► No reconocido socialmente (perinatal, suicidio, mascotas, exparejas) [DOKA]
    ├── DUELO AMBIGUO       ──► Ausencia física/Presencia psíquica O viceversa (demencias) [BOSS]
    ├── DUELO MIGRATORIO    ──► Pérdidas múltiples y simultáneas. Síndrome de Ulises [ACHOTEGUI]
    └── DUELO PROLONGADO    ──► Patológico. CIE-11: >6 meses | DSM-5-TR: >12 meses (>6 meses menores)

 3. METODOLOGÍA DEL PLAN SOCIOEDUCATIVO ANTE EL DUELO
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ ROL DEL EDUCADOR/A SOCIAL:                                               │
    │ * Normalización y alfabetización emocional (prohibición de eufemismos nocivos).  │
    │ * Reorganización de la vida cotidiana en el hogar (rutinas, descanso, comidas).  │
    │ * Técnicas de expresión en infancia (dibujo, plastilina, cuentos, memory box).   │
    │ * Coordinación técnica con centro escolar (tutor, EOE, protocolos de aula).      │
    │ * Facilitación de rituales de despedida y procesos de cierre (carta gratitud).   │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 4. RESOLUCIÓN SALUDABLE DEL DUELO
    ├── Recordar con serenidad y gratitud sin parálisis funcional.
    ├── Reanudar actividades formativas, laborales y de ocio normalizadas.
    └── Capacidad de establecer nuevos apegos y trazar proyectos vitales de futuro.
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa sobre la secuencialidad rígida de las fases de Kübler-Ross**:

- *Enunciado trampa*: *"Según la teoría de Elisabeth Kübler-Ross, toda persona en duelo debe atravesar de manera lineal y consecutiva las etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación, sin que sea posible retroceder ni omitir fases."*

- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Las etapas descritas por Kübler-Ross son **dinámicas, no lineales y oscilatorias**. El doliente puede fluctuar entre varias fases, retroceder ante aniversarios o no manifestar alguna de ellas sin que ello signifique patología.

1. **Trampa sobre el concepto de Luto vs. Duelo**:

- *Enunciado trampa*: *"El luto alude a la vivencia psicológica íntima y subjetiva ante la pérdida, mientras que el duelo es el conjunto de convenciones y rituales sociales."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Los términos están invertidos: el **Duelo (*Grief*)** es la respuesta subjetiva, interna y biopsicosocial; el **Luto (*Mourning*)** es la manifestación externa, conductual y cultural prescrita por la sociedad.

1. **Trampa sobre la cuarta tarea de William Worden**:

- *Enunciado trampa*: *"La cuarta tarea del duelo según William Worden consiste en olvidar definitivamente a la persona fallecida para poder enamorarse de otra persona."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La cuarta tarea formulada por Worden consiste en **recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo**. No se trata de olvidar ni desvincularse, sino de ubicar su memoria en un lugar afectivo adecuado que permita reinvertir la energía vital en el presente y el futuro.

1. **Trampa sobre el criterio temporal del Duelo Prolongado en el DSM-5-TR**:

- *Enunciado trampa*: *"El DSM-5-TR establece que el Trastorno de Duelo Prolongado solo puede diagnosticarse tras haber transcurrido al menos 24 meses desde la muerte en adultos."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El criterio temporal fijado por el DSM-5-TR es de **al menos 12 meses en adultos** y de **al menos 6 meses en niños y adolescentes** (la CIE-11 fija 6 meses de forma general).

1. **Trampa sobre el duelo desautorizado (*Disenfranchised Grief*)**:

- *Enunciado trampa*: *"El duelo desautorizado es aquel que experimenta una persona que ha sufrido una pérdida que el Código Penal castiga con inhabilitación judicial."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El duelo desautorizado (concepto acuñado por Kenneth Doka) es aquel duelo por una pérdida que **no es validada, reconocida o apoyada abiertamente por la sociedad o el entorno cultural** (como la muerte perinatal, el suicidio, pérdidas de amantes o animales de compañía).

1. **Trampa sobre la delimitación funcional entre Educación Social y Psicología**:

- *Enunciado trampa*: *"El Educador Social que interviene en un Centro de Servicios Sociales Comunitarios ante un duelo infantil debe aplicar técnicas de psicoterapia clínica y desensibilización por movimientos oculares (EMDR)."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El Educador/a Social realiza un **acompañamiento socioeducativo en el medio natural, estructuración de la vida diaria y alfabetización emocional**. La psicoterapia clínica, el tratamiento del trauma y las técnicas específicas como EMDR son competencia exclusiva de profesionales de la Psicología o Psiquiatría.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

En el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32), la Trabajadora Social de Zona deriva con carácter urgente al **Técnico/a Medio de Educación Social** del Equipo de Infancia y Familia la intervención en la unidad familiar compuesta por Rocío (38 años) y sus dos hijos: Alejandro (8 años) y Claudia (14 años).

Circunstancias de la pérdida expuestas en la derivación:

- El padre de los menores falleció de forma repentina hace dos meses a causa de un infarto fulminante en el domicilio.
- Desestructuración severa de la vida cotidiana en el hogar: la madre permanece en cama en estado de abatimiento profundo, sin cocinar ni realizar tareas domésticas; la nevera está vacía y se acumula la suciedad.
- Afectación en los menores:
- Claudia (14 años, alumna de 2º ESO en el IES Ruiz Gijón de Utrera): Ha asumido el rol de cuidadora de su madre y hermano menor (parentificación), presentando absentismo escolar intermitente (ha dejado de asistir a clase los viernes y primeras horas de la mañana para cuidar de la casa).
- Alejandro (8 años, alumno de 3º Primaria en el CEIP Rodrigo Caro de Utrera): Manifiesta terrores nocturnos, enuresis secundaria y mutismo selectivo en el colegio. La madre le dijo que *"papá se ha dormido y se ha ido a hacer un viaje muy largo al cielo"*, por lo que el menor se niega a dormir solo por temor a morir dormido y pregunta a diario a qué hora regresa el padre.

Plan de Trabajo Socioeducativo del Educador/a Social de Utrera:

1. **Fase de Valoración y Coordinación Interdisciplinar**:

- Entrevista en despacho y visita domiciliaria inmediata. Se constata colapso funcional del hogar, bloqueo de la Tarea 1 de Worden en el menor (negación de la irreversibilidad fomentada por el eufemismo materno) y sobrecarga en la adolescente.
- Coordinación interna con la Psicóloga del centro para que inicie apoyo psicoterapéutico individualizado con la madre en calle Catalina de Perea.
- Tramitación con la Trabajadora Social de una **Ayuda Económica Familiar (AEF)** de urgencia y del apoyo técnico de un Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para tareas de choque en el hogar.

1. **Diseño y Ejecución del Plan Socioeducativo en el Hogar**:

- **Alfabetización y verdad pedagógica con el menor**: En sesión conjunta guiada por el Educador/a Social, se apoya a la madre para desmontar el eufemismo dañino. Se le explica con serenidad y afecto a Alejandro que papá murió físicamente, que su corazón dejó de latir, que no siente dolor y que no puede volver, desvinculando la muerte del sueño para erradicar los terrores nocturnos.
- **Reorganización de la vida cotidiana y desparentificación de la adolescente**:
- Confección de un cuadrante visible de rutinas diarias: horarios de levantarse (07:30 h), desayunos estructurados y reparto equitativo de tareas.
- Liberar a Claudia de responsabilidades adultas de cuidado para permitir su reincorporación plena al IES Ruiz Gijón y a sus actividades de ocio con su grupo de iguales.

1. **Coordinación con los Centros Educativos de Utrera**:

- Reunión de coordinación con los tutores y orientadores del **CEIP Rodrigo Caro** y del **IES Ruiz Gijón**.
- Pautas socioeducativas en el aula para Alejandro: habilitar un "rincón de calma" donde pueda retirarse si experimenta llanto o angustia sin ser penalizado; uso del dibujo libre como canal de desahogo; y evitar preguntas invasivas en clase.
- Seguimiento diario de asistencia con el **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)** para supervisar la regularización de la asistencia de Claudia.

1. **Rituales Pedagógicos de Despedida y Cierre**:

- Alejandro y Claudia no pudieron acudir al sepelio por decisión de la familia para "protegerlos". El Educador/a Social trabaja con ellos la elaboración de una **Caja de Recuerdos (*Memory Box*)**, donde guardan

fotografías familiares, una corbata y un reloj del padre.

- Con Claudia se realiza la técnica de la **Carta de despedida y gratitud**, facilitando la expresión de sus emociones y despidiéndose formalmente.
- Se acompaña a la familia a visitar el Cementerio Municipal de Utrera en un acto íntimo y preparado pedagógicamente, cerrando el rito de despedida no realizado.

1. **Evaluación a los 6 meses**:

- Desaparición de la enuresis y terrores nocturnos en Alejandro, con rendimiento escolar normalizado.
- Asistencia regular del 100% de Claudia al IES Ruiz Gijón y recuperación de sus salidas con amigos.
- Madre estabilizada y asumiendo plenamente el liderazgo de las tareas domésticas y parentales. Emisión de informe socioeducativo favorable de consecución de objetivos.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Especializada

1. **Clásicos y Manuales de Referencia en Duelo**:

- **Kübler-Ross, Elisabeth** (1969). *On Death and Dying*. Macmillan (Ed. esp.: *Sobre la muerte y los moribundos*, Grijalbo).
- **Bowlby, John** (1980). *Attachment and Loss: Vol. 3. Loss: Sadness and Depression*. Basic Books (Ed. esp.: *La pérdida afectiva*, Paidós).
- **Worden, J. William** (2009). *Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner* (4th ed.). Springer Publishing (Ed. esp.: *El tratamiento del duelo: Asesoramiento psicológico y terapia*, Paidós, 2013).
- **Stroebe, Margaret & Schut, Henk** (1999). *The dual process model of coping with bereavement: Rationale and description*. Death Studies, 23(3), 197-224.
- **Neimeyer, Robert A.** (2001). *Meaning Reconstruction and the Experience of Loss*. American Psychological Association (Ed. esp.: *Aprender de la pérdida: Una guía para afrontar el duelo*, Paidós).
- **Doka, Kenneth J.** (1989). *Disenfranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow*. Lexington Books.
- **Boss, Pauline** (1999). *Ambiguous Loss: Learning to Live with Unresolved Grief*. Harvard University Press.

1. **Manuales Diagnósticos Oficiales**:

- **Organización Mundial de la Salud (OMS)** (2022). *Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª revisión (CIE-11)*. Código 6B42: Trastorno por duelo prolongado.
- **American Psychiatric Association (APA)** (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. Criterios de Prolonged Grief Disorder.

1. **Marco Autonómico Andaluz**:

- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*). Artículos 30 y 31 (equipos interdisciplinares y profesional de referencia).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.